

Disfonía crónica: causas y estudio

1. Introducción y relevancia clínica

La **disfonía** se define como **cualquier alteración de la voz** que afecta su **timbre, intensidad, tono o duración**, percibida por el paciente o su entorno. Cuando persiste **más de 3 semanas**, se denomina **disfonía crónica**, y debe **siempre estudiarse** para descartar causas graves, incluyendo **cáncer laríngeo**.

Epidemiología

- Afecta hasta el **30% de la población** en algún momento.
- Más frecuente en:
 - Profesiones con sobreuso vocal (profesores, cantantes, locutores).
 - Fumadores.
 - Pacientes con reflujo gastroesofágico o exposición a irritantes.
- En adultos mayores, la **disfonía crónica es un síntoma de alarma** para cáncer de laringe o parálisis de cuerda vocal.

Relevancia clínica

- Es un **motivo frecuente de consulta en APS y ORL**.
 - Permite detectar precozmente patologías **benignas (nódulos, pólipos)** o **malignas (carcinoma glótico)**.
 - En EUNACOM, es **pregunta recurrente**: se evalúan causas, red flags y criterios de derivación a ORL.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Anatomía funcional de la voz

La voz se genera por el **paso del aire pulmonar** a través de la **laringe**, haciendo vibrar las **cuerdas vocales**.

Participan:

- **Pulmones** → flujo de aire.
 - **Laringe** → fonación.
 - **Faringe, cavidad oral y nasal** → resonancia.
 - **Sistema nervioso central y periférico** → control y coordinación.
-

2.2 Mecanismo de la disfonía

Cualquier alteración en la anatomía o fisiología de este sistema puede generar disfonía:

Mecanismo	Ejemplo
Inflamatorio	Laringitis aguda o crónica.
Funcional	Mal uso o abuso vocal, tensión muscular.
Estructural benigno	Nódulos, pólipos, quistes.
Neurológico	Parálisis de cuerda vocal (daño del nervio laríngeo recurrente).
Neoplásico	Carcinoma de cuerdas vocales.
Reflujo laringofaríngeo	Irritación crónica de la mucosa laríngea.

2.3 Clasificación etiológica

1. **Disfonías funcionales (sin lesión anatómica):**

- Uso inadecuado o excesivo de la voz (profesores, cantantes).
- Tensión muscular laríngea (disfonía psicógena o hipercinética).
- Habitual en mujeres jóvenes y ansiosas.

2. **Disfonías orgánicas benignas:**

- Nódulos vocales (bilaterales, simétricos).
- Pólipos (unilateral, pediculado).
- Quistes o granulomas postintubación.
- Papilomatosis laríngea.

3. **Disfonías por causas neurológicas:**

- Parálisis unilateral o bilateral del nervio laríngeo recurrente (tumor, cirugía tiroidea, iatrogénica).
- Enfermedad de Parkinson, distonía laríngea.

4. **Disfonías orgánicas malignas:**

- Carcinoma epidermoide de laringe (principalmente en glotis).
- Factores de riesgo: **tabaco + alcohol**, VPH tipo 16 y 18.

5. **Disfonía secundaria a reflujo laringofaríngeo (RLF):**

- Irritación crónica de mucosa por ácido gástrico ascendente.
- Tos seca, aclaramiento frecuente, disfonía matinal.

3. **Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)**

3.1 **Síntomas principales**

- Voz ronca, áspera, entrecortada o con cambios de tono.
- Fatiga vocal, necesidad de aclarar la garganta.

- Sensación de cuerpo extraño o carraspeo.
 - Dolor o ardor laríngeo.
 - Tos seca crónica.
 - En casos graves: **afonía** o **pérdida total de la voz**.
-

3.2 Signos de alarma (red flags)

☐ Toda disfonía >3 semanas con alguno de los siguientes signos requiere derivación urgente a ORL:

1. Disfonía persistente en **fumadores**.
 2. **Hemoptisis** o **odinofagia intensa**.
 3. **Dolor otálgico referido** unilateral.
 4. **Disfagia** o **masa cervical palpable**.
 5. **Estridor** o **dificultad respiratoria**.
 6. Antecedente de **intubación reciente** o cirugía cervical/tiroidea.
 7. Disfonía progresiva sin causa evidente.
-

3.3 Diagnóstico diferencial según características clínicas

Causa	Características clínicas distintivas
Disfonía funcional	Voz variable, empeora con estrés, examen laríngeo normal.
Nódulos vocales	Bilaterales, simétricos, ronquera crónica, sobreuso vocal.
Pólipo	Unilateral, inicio súbito tras esfuerzo vocal.

Laringitis crónica	Voz ronca continua, tos seca, fumadores.
Reflujo laringofaríngeo	Disfonía matinal, carraspeo, pirosis, sensación de globo faríngeo.
Parálisis de cuerda vocal	Voz soplada, aspiración de líquidos, cierre glótico incompleto.
Carcinoma glótico	Disfonía progresiva sin dolor; en etapas avanzadas, odinofagia, masa cervical.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Evaluación inicial en APS

- **Historia clínica detallada** (duración, exposición, reflujo, tabaco, profesiones de voz).
- **Examen físico general y ORL básico:**
 - Evaluar cavidad oral, faringe, cuello (masa, adenopatías).
 - Si no hay signos de alarma y <3 semanas → manejo conservador inicial.

4.2 Evaluación ORL especializada

Examen	Utilidad
Laringoscopia indirecta o fibro-laringoscopia	Evaluación directa de las cuerdas vocales (presencia de lesiones, movilidad, cierre glótico).

Videolaringoestroboscopia	Permite estudiar vibración mucosa y distinguir lesiones benignas.
TAC o RM cervical	Si sospecha lesión tumoral o parálisis.
Estudio funcional de la voz / foniatría	En disfonías funcionales o postquirúrgicas.
pH-metría o prueba terapéutica	Si se sospecha reflujo laringofaríngeo.

4.3 Diagnóstico

- **Clínico y endoscópico.**
 - En casos de lesiones sólidas, se requiere **biopsia** para confirmar o descartar neoplasia.
 - Toda **disfonía persistente >3 semanas sin causa evidente** → **debe estudiarse con laringoscopia.**
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

El tratamiento depende de la causa, pero **toda disfonía crónica requiere medidas de higiene vocal.**

5.1 Medidas generales (higiene vocal)

- Evitar gritar, susurrar o hablar en ambientes ruidosos.
- Hidratar adecuadamente (≥ 2 L/día).
- Evitar tabaco, alcohol y cafeína.
- Dormir adecuadamente.

- No aclarar la garganta repetidamente.
- Tratar alergias y reflujo si presentes.
- Educación vocal con **fonoaudiólogo especializado en voz**.

5.2 Tratamiento específico según etiología

Causa	Tratamiento
Laringitis crónica / irritativa	Corticoide tópico corto plazo, evitar irritantes, tratar causa (tabaco, reflujo).
Nódulos / pólipos vocales	Fonoaudiología + cirugía micro-laríngea si no resuelven tras 3 meses.
Parálisis de cuerda vocal	Rehabilitación vocal o medialización quirúrgica (inyección de grasa o teflón).
Papilomatosis laríngea	Microcirugía láser y antivirales adyuvantes.
Reflujo laringofaríngeo	Inhibidor de bomba de protones (omeprazol 40 mg/día por 8–12 semanas), dieta antirreflujo.
Carcinoma laríngeo	Manejo oncológico multidisciplinario (cirugía, radioterapia o quimioterapia).

5.3 Derivación a ORL

Derivar en APS todo paciente con:

- Disfonía >3 semanas.

- Fumador o antecedente de cáncer.
 - Síntomas de alarma.
 - Sospecha de parálisis o masa cervical.
 - Fracaso de tratamiento conservador.
-

6. Complicaciones y pronóstico

6.1 Complicaciones

- **Lesiones permanentes de las cuerdas vocales** por mal uso no tratado.
 - **Pérdida profesional de la voz** en trabajadores vocales.
 - **Estenosis laríngea postintubación.**
 - **Neoplasia laríngea** en diagnóstico tardío.
 - **Aspiration y disnea** en parálisis bilateral.
-

6.2 Pronóstico

- **Excelente** en disfonías funcionales y benignas con manejo fonoaudiológico.
 - En lesiones estructurales (nódulos, pólipos), la cirugía tiene alta tasa de recuperación.
 - **Carcinoma laríngeo glótico** diagnosticado precozmente tiene **>90% de sobrevida a 5 años.**
 - El pronóstico depende del diagnóstico temprano y de la **rehabilitación vocal adecuada.**
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. Toda **disfonía que dure >3 semanas** debe estudiarse con **laringoscopia**.
 2. **Fumador con disfonía crónica = cáncer laríngeo hasta demostrar lo contrario.**
 3. **Nódulos bilaterales** en profesionales de la voz → manejo fonoaudiológico.
 4. **Pólipo unilateral** posterior a esfuerzo vocal → posible cirugía micro-laríngea.
 5. **Reflujo laringofaríngeo** causa frecuente de disfonía matinal; mejora con IBP.
 6. Evitar **antibióticos o corticoides sistémicos** sin diagnóstico preciso.
 7. La **rehabilitación vocal** es pilar terapéutico en la mayoría de los casos.
-

Errores comunes

- Tratar con antibióticos sin evidencia de infección.
 - No derivar disfonía persistente.
 - Ignorar síntomas de alarma (fumador, hemoptisis, masa cervical).
 - Abusar de corticoides orales sin diagnóstico.
 - No corregir malos hábitos vocales (gritar, hablar sobre ruido).
 - Omitir el componente psicológico o tensional de la disfonía funcional.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **disfonía crónica** es toda alteración de la voz >3 semanas.
2. Causas principales: **uso inadecuado, reflujo laringofaríngeo, lesiones benignas y carcinoma glótico.**
3. **Fumador con disfonía persistente** → **sospechar cáncer laríngeo.**
4. El **diagnóstico se confirma por laringoscopia directa o flexible.**

5. **Medidas de higiene vocal + fonoaudiología** son la base del manejo inicial.
6. Tratar causas específicas: reflujo, pólipos, parálisis o neoplasias.
7. Pronóstico excelente si se diagnostica y maneja precozmente; prevenir recurrencias con educación vocal.